

RESUMO DA PSICANÁLISE (1924)

TÍTULO ORIGINAL: "KURZER ABRIS
DER PSYCHOANALYSE". PUBLICADO
PRIMEIRAMENTE EM VERSÃO INGLESA,
NO VOLUME THESE EVENTFUL YEARS:
THE 20TH CENTURY IN THE MAKING,
AS TOLD BY MANY OF ITS MAKERS
(NOVA YORK: ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA
CO., 1924). PRIMEIRA EDIÇÃO ALEMÃ:
GESAMMELTE SCHRIFTEN XI, PP. 183-200
(1928). TRADUZIDO DE GESAMMELTE
WERKE XIII, PP. 403-27.

A psicanálise nasceu com o século xx, por assim dizer. A publicação com que se apresentou ao mundo como algo novo, minha *Interpretação dos sonhos*, tem a data de 1900. Mas, naturalmente, não brotou das rochas nem caiu do céu. Liga-se a coisas anteriores, a que dá prosseguimento; resulta de estímulos que veio a elaborar. Então sua história tem de começar com a posição das influências que foram decisivas em sua gênese, e não pode esquecer o tempo e as circunstâncias anteriores à sua criação.

A psicanálise cresceu num terreno bem delimitado. Seu objetivo, originalmente, era apenas conhecer algo sobre a natureza das doenças nervosas denominadas “funcionais”, a fim de superar a impotência médica no tratamento de tais doenças. Os neurologistas de então haviam sido educados no alto respeito aos fatos químico-físicos e anatômico-patológicos; estavam, por fim, sob a influência dos achados de Von Hitzig e Fritsch, Ferrier, Goltz e outros, que parecem demonstrar uma ligação íntima, talvez exclusiva, entre certas funções e determinadas partes do cérebro. Sobre o fator psíquico não viam o que dizer, não podiam apreendê-lo, deixavam-no para os filósofos, místicos e... charlatães, e também consideravam pouco científico lidar com ele. Em consequência, não achavam acesso aos segredos das neuroses, sobretudo da misteriosa “histeria”, que constituía o modelo de todo o gênero. Ainda em 1885, quando frequentei aulas na Salpêtrière,* soube que, em relação às paralisias histéricas, os especialistas contentavam-se com a fórmula de que elas se deviam a leves transtornos funcionais das mesmas partes do

cérebro que, em caso de lesão grave, gerariam a paralisia orgânica correspondente.

Naturalmente, a terapia desses estados patológicos também era afetada pela ausência de compreensão. Ela consistia em medidas geralmente “tonificantes”, na prescrição de remédios e em tentativas de exercer influência psíquica, na maioria das vezes inadequadas e executadas de forma rude, como intimidações, zombarias, exortações a valer-se da própria vontade, “controlar-se”. Especificamente para os estados nervosos recomendava-se o tratamento elétrico, mas quem buscasse aplicá-lo conforme as instruções detalhadas de W. Erb tinha de surpreender-se com o espaço que mesmo numa ciência supostamente exata a imaginação podia ocupar. A mudança decisiva ocorreu quando, na década de 1880, os fenômenos do hipnotismo novamente requereram admissão na ciência médica — com êxito maior do que em muitas ocasiões anteriores, graças ao trabalho de Liébault, Bernheim, Heidenhain e Forel. A questão era, antes de tudo, que a autenticidade desses fenômenos fosse reconhecida. Uma vez admitido isso, duas lições fundamentais e ineludíveis eram inevitavelmente extraídas do hipnotismo. Primeiro, chegou-se à convicção de que evidentes mudanças físicas eram apenas o resultado de influências psíquicas que o hipnotizador mesmo havia provocado; segundo, adquiriu-se a mais clara impressão, sobretudo a partir do comportamento das pessoas após a hipnose, da existência dos processos psíquicos que só podiam ser denominados “inconscientes”. É certo que havia muito o inconsciente era discutido pelos filósofos como um conceito teórico, mas nos fenômenos do hipnotismo ele se tornou pela primeira vez concreto, palpável e objeto de experimento. Além disso, tais

fenômenos mostravam inconfundível semelhança com as manifestações de algumas neuroses.

Difícilmente se pode exagerar a importância do hipnotismo no surgimento da psicanálise. Seja no aspecto teórico, seja no terapêutico, a psicanálise administra um legado que herdou do hipnotismo.

A hipnose também demonstrou ser de grande auxílio no estudo das neuroses — principalmente da histeria. Produziram enorme impressão os experimentos de Charcot. Ele supôs que certas paralisias, que surgiam após um trauma (um acidente), eram de natureza histerica, e pôde provocar artificialmente, pela sugestão de um trauma durante a hipnose, paralisias com as mesmas características. Disso resultou a expectativa de que as experiências traumáticas possam, de maneira geral, participar da gênese dos sintomas histericos. Charcot mesmo não se empenhou numa compreensão psicológica da neurose histerica, mas seu discípulo Pierre Janet retomou esses estudos e, com o auxílio da hipnose, pôde mostrar que os sintomas da histeria se acham em estreita ligação com determinados pensamentos inconscientes (*idéés fixes*). Para Janet, a histeria se caracterizava por uma incapacidade constitucional de manter unidos os processos psíquicos, da qual resultaria uma dissociação** da vida psíquica.

No entanto, a psicanálise não partiu absolutamente dessas pesquisas de Janet. Para ela foi determinante a experiência de um médico de Viena, o dr. Josef Breuer. Em 1881, de forma independente, ele pôde estudar e curar, com ajuda da hipnose, uma moça altamente dotada que sofria de histeria. Apenas quinze anos mais tarde as conclusões de Breuer foram publicadas, após ele tomar o presente autor (Freud) como colaborador. O caso por

ele tratado conserva até hoje uma importância única para a nossa compreensão das neuroses, de maneira que é imprescindível examiná-lo com mais vagar. É necessário apreender claramente a peculiaridade desse caso. A garota adoeceu enquanto cuidava do pai que muito amava. Breuer pôde demonstrar que todos os sintomas se ligavam à assistência ao pai e nela encontravam explicação. Pela primeira vez, um enigmático caso de neurose foi inteiramente penetrado e todas as suas manifestações patológicas revelaram-se dotadas de sentido. Além do mais, era característica geral dos sintomas que eles haviam surgido em situações envolvendo um impulso^{***} para uma ação que não fora levado a efeito, mas suprimido por causa de outros motivos. No lugar dessas ações omitidas apareceram justamente os sintomas. Assim, quanto à etiologia dos sintomas históricos éramos remetidos à vida emocional (afetividade) e ao jogo das forças psíquicas (dinamismo), e desde então esses dois aspectos nunca foram abandonados.

Breuer equiparou os ensejos para o surgimento dos sintomas aos traumas de Charcot. Era notável que esses ensejos traumáticos e todos os impulsos psíquicos a eles ligados estivessem perdidos para a memória da paciente, como se jamais tivessem ocorrido, enquanto seus efeitos, os sintomas, permaneciam inalterados, como se para eles não houvesse desgaste pelo tempo. Portanto, encontrou-se aí uma nova prova da existência de processos psíquicos inconscientes, mas por isso mesmo particularmente poderosos, tais como havíamos encontrado primeiramente nas sugestões pós-hipnóticas. O procedimento terapêutico de Breuer consistia em induzir a enferma, sob hipnose, a recordar os traumas esquecidos e reagir a eles com intensas exteriorizações de afeto. Com isso desaparecia o sintoma que até então

estava no lugar dessas exteriorizações emocionais. Portanto, o mesmo procedimento servia simultaneamente à pesquisa e à eliminação da enfermidade, e também essa inusual combinação foi depois mantida na psicanálise.

Após o presente autor confirmar os resultados de Breuer em bom número de pacientes, nos primeiros anos da década de 1890, os dois, Breuer e Freud, decidiram fazer uma publicação que contivesse suas experiências e a tentativa de uma teoria nela baseada (*Estudos sobre a histeria*, 1895). Essa teoria afirmava que o sintoma histérico surge quando o afeto de um processo psíquico bastante investido afetivamente é afastado^{*} da elaboração consciente normal e, assim, encaminhado por uma via errada. Então ele se converte, no caso da histeria, em inusual intervenção somática (conversão), mas, com a reanimação da vivência durante a hipnose, pode ser guiado para outra direção e “despachado” (ab-reação). Os autores chamaram seu procedimento de “catarse” (purificação, liberação do afeto sufocado).

O método catártico é o precursor direto da psicanálise e nela permanece como núcleo, apesar de todos os acréscimos na experiência e todas as modificações na teoria. Mas ele não era senão uma nova maneira de influir clinicamente sobre determinadas doenças nervosas, e nada indicava que pudesse vir a ser objeto do interesse geral e da mais veemente oposição.

II

Pouco depois da publicação dos *Estudos sobre a histeria* teve fim a colaboração de Breuer e Freud. O primeiro, que se ocupava propriamente da medicina interna, abandonou o tratamento de

doenças nervosas. O segundo empenhou-se em continuar aperfeiçoando o instrumento que lhe deixara o colega mais velho; as inovações técnicas que introduziu e as descobertas que fez transformaram o método catártico na psicanálise. O passo mais premente de consequências foi sua decisão de renunciar ao auxílio técnico da hipnose. Fez isso por dois motivos: primeiro, porque não eram muitos os pacientes que conseguia pôr em hipnose, embora tivesse feito um curso com Bernheim em Nancy; segundo, porque estava insatisfeito com os resultados terapêuticos da catarse baseada na hipnose. Esses resultados eram patentes e surgiam após um breve período de tratamento, mas revelavam-se pouco duradouros e muito dependentes da relação pessoal do paciente com o médico. O abandono da hipnose significou uma ruptura com o método até então desenvolvido e um novo começo.

Mas a hipnose realizava o serviço de conduzir à lembrança consciente o que fora esquecido pelo doente. Era necessário substituí-la por outra técnica. Então ocorreu a Freud a ideia de trocá-la pelo método da associação livre; isto é, requereu que os doentes abandonassem toda reflexão consciente e em tranqüila concentração se entregassem ao curso de seus pensamentos espontâneos ou involuntários (“a tatear a superfície de sua consciência”). Deviam comunicar ao médico tais pensamentos, ainda quando tivessem objeções a eles; como, por exemplo, de que o pensamento era muito desagradável, absurdo ou impertinente. A escolha da livre associação como meio para pesquisar o material inconsciente esquecido parece tão estranha que não será inútil despendar algumas palavras em sua justificação. Freud tinha a expectativa de que a “livre associação” se revelaria não livre, na realidade, uma vez que, após a supressão de toda

intenção de pensar conscientemente, ficaria claro que os pensamentos eram determinados pelo material inconsciente. Essa expectativa foi justificada pela experiência. Seguindo a livre associação, obedecendo à mencionada “regra psicanalítica fundamental”, obtínhamos um rico material de coisas que vinham à mente do paciente, que podiam nos levar à pista do que ele havia esquecido. Embora esse material não trouxesse o que fora esquecido mesmo, continha claras e numerosas alusões a ele, de forma que o médico podia adivinhar (reconstruir) o esquecido com determinadas complementações e interpretações. Associação livre e arte interpretativa realizavam o mesmo que a hipnotização anteriormente.

Aparentemente havíamos dificultado e complicado o trabalho para nós mesmos; mas o ganho inestimável era obtermos compreensão de um jogo de forças que no estado hipnótico se ocultava ao observador. Percebemos que o trabalho de descobrir o patogenicamente esquecido precisava lutar contra uma resistência constante e muito intensa. Já eram manifestações dessa resistência as objeções críticas com que o paciente procurava excluir da comunicação os pensamentos que lhe ocorriam, e contra as quais era dirigida a regra psicanalítica fundamental. Foi a partir da consideração dos fenômenos da resistência que nasceu um dos pilares da doutrina psicanalítica das neuroses, a teoria da repressão. Era plausível imaginar que as mesmas forças que então se opunham a que o material patogênico se tornasse consciente haviam se empenhado antes da mesma forma, com sucesso. Preenchia-se então uma lacuna na etiologia dos sintomas neuróticos. As impressões e os impulsos psíquicos, para os quais os sintomas estavam servindo de substitutos, não foram esquecidos sem qualquer fundamento ou devido a uma

incapacidade constitucional para a síntese, como pensava Janet. Ocorreu, isto sim, que, por influência de outras forças psíquicas, experimentaram uma repressão cujo êxito e indício era justamente o fato de serem mantidos fora da consciência e excluídos da lembrança. Apenas devido a essa repressão tornaram-se patológicos, isto é, por caminhos inusuais adquiriram expressão como sintomas.

Era preciso ver o conflito entre dois grupos de tendências psíquicas como o motivo da repressão e, assim, como causa de todo adoecimento neurótico. E então a experiência mostrava um novo e surpreendente fato sobre a natureza das forças em conflito. Via de regra, a repressão partia da personalidade consciente (do Eu) do paciente, invocando motivos éticos e estéticos; eram atingidos por ela impulsos de egoísmo e crueldade geralmente considerados maus, mas sobretudo desejos sexuais, com frequência da espécie mais crua e mais proibida. Os sintomas patológicos eram, portanto, um substituto para satisfações proibidas, e a doença parecia corresponder a uma imperfeita subjugação do que há de imoral no ser humano.

O progresso no conhecimento tornou cada vez mais claro o papel imenso que os desejos sexuais têm na vida psíquica e ensinou um estudo mais detido sobre a natureza e o desenvolvimento do instinto sexual (Freud, *Três ensaios de uma teoria da sexualidade*, 1905). Mas também chegamos a outro resultado, puramente empírico, ao descobrir que as vivências e os conflitos dos primeiros anos infantis têm insuspeitada importância no desenvolvimento do indivíduo e deixam predisposições indeléveis para a idade adulta. Assim viemos a desvendar algo que a ciência até então ignorara, a sexualidade infantil, que desde a mais tenra

idade se manifesta em reações físicas e em atitudes psíquicas. Para conciliar essa sexualidade infantil com o que se chama sexualidade normal dos adultos e vida sexual anormal dos pervertidos, foi preciso que o conceito de sexual mesmo experimentasse uma retificação e ampliação, que pôde ser justificada pela história do desenvolvimento do instinto sexual.

Depois que a hipnose foi substituída pela técnica da associação livre, o procedimento catártico de Breuer transformou-se em psicanálise, que por mais de uma década foi desenvolvida apenas por este autor (Freud). Durante esse tempo, a psicanálise gradualmente chegou à posse de uma teoria que parecia dar explicação suficiente sobre a gênese, o sentido e o propósito dos sintomas neuróticos e fornecia um fundamento racional aos esforços médicos para eliminar a doença. Vou mais uma vez relacionar os fatores que formam o conteúdo dessa teoria. Eles são: a ênfase na vida instintual (afetividade), na dinâmica psíquica, no fato de mesmo os fenômenos psíquicos aparentemente mais obscuros e arbitrários sempre serem determinados e dotados de sentido, a teoria do conflito psíquico e da natureza patogênica da repressão, a concepção dos sintomas patológicos como satisfações substitutivas, o reconhecimento da importância etiológica da vida sexual, em especial dos começos da sexualidade infantil. No aspecto filosófico, essa teoria tinha que adotar concepção de que o psíquico não coincide com o consciente, de que os processos psíquicos são inconscientes em si e apenas mediante o funcionamento de órgãos especiais (instâncias, sistemas) são tornados conscientes. Acrescentarei, completando essa enumeração, que entre as atitudes afetivas da infância destacou-se a complicada relação emocional com os pais, o chamado “complexo de Édipo”, no qual reconhecemos cada vez mais

claramente o núcleo de todo caso de neurose, e que na conduta do analisando perante o médico chamaram a atenção determinando dos fenômenos de transferência emocional, que adquiriram enorme significado tanto na teoria como na técnica.

Já nessa configuração a teoria psicanalítica das neuroses continha vários elementos que contrariavam as opiniões e inclinações vigentes e podiam suscitar estranheza, aversão e descrença nos observadores. Por exemplo, a posição ante o problema do inconsciente, o reconhecimento de uma sexualidade infantil e a ênfase dada ao fator sexual na vida psíquica em geral; mas outros se juntariam a esses.

III

Para mais ou menos compreender como, numa garota histérica, um desejo sexual proibido pode se transformar num sintoma doloroso, fora necessário fazer intrincadas e abrangentes suposições relativas à estrutura e à função do aparelho psíquico. Era evidente a desproporção entre o dispêndio e o resultado. Se realmente existiam as condições postuladas pela psicanálise, elas eram de natureza fundamental e tinham de poder se manifestar igualmente em outros fenômenos que não os histéricos. Mas, sendo correta essa conclusão, a psicanálise deixaria de interessar apenas aos neurologistas; podia requerer a atenção de todos os que atribuíam importância à pesquisa psicológica. Seus resultados não diziam respeito apenas ao âmbito da vida psíquica patológica; eles tampouco podiam ser negligenciados para a compreensão do funcionamento normal.

A prova de sua utilidade no esclarecimento da atividade psíquica não patológica chegou bem cedo para a psicanálise, em relação com dois tipos de fenômeno: nos frequentes atos falhos cotidianos, como esquecimento, lapso, mudança involuntária do local de um objeto etc.; e nos sonhos de pessoas sadias e psiquicamente normais. Os pequenos atos falhos, como o temporário esquecimento de nomes próprios que sabemos, os lapsos de fala, de escrita e coisas afins, não eram vistos como merecedores de explicação ou eram atribuídos ao cansaço, à desatenção etc. O presente autor demonstrou com numerosos exemplos, em seu livro *Psicopatologia da vida cotidiana* (1901), que tais ocorrências são dotadas de sentido e surgem devido à perturbação de uma intenção consciente por outra intenção, suprimida, muitas vezes inconsciente. Geralmente basta uma breve reflexão ou uma rápida análise para se encontrar a influência perturbadora. Dada a frequência desses atos falhos, dos lapsos de fala, sobretudo, é fácil para qualquer um convencer-se por experiência própria da existência de processos psíquicos não conscientes, mas que são atuantes e acham expressão pelo menos como inibições e modificações de outros atos, esses intencionais.

Conduziu-nos mais adiante a análise dos sonhos, que o presente autor apresentou ao público já em 1900, na *Interpretação dos sonhos*. Nela se constatou que o sonho não é construído diferentemente de um sintoma neurótico. Ele pode, como este, parecer estranho e sem sentido; mas, se o investigamos mediante uma técnica que pouco se diferencia da livre associação usada na psicanálise, chegamos, partindo de seu conteúdo manifesto, ao sentido oculto, aos pensamentos latentes do sonho. Tal sentido latente é sempre um desejo que é mostrado

como realizado no presente. No entanto, exceto no caso de criações pequenas ou sob a pressão de necessidades físicas imperiosas, esse desejo secreto não pode jamais ser expresso de forma reconhecível. Ele tem que submeter-se antes a uma deformação, obra de forças restritivas, censuradoras, que se acham no Eu do sonhador. Desse modo surge o sonho manifesto como é recordado na vida desperta, deformado, até ficar irreconhecível, pelas concessões feitas à censura onírica; mas podendo ser revelado pela análise como expressão de um estado de satisfação ou cumprimento de um desejo, um compromisso entre dois grupos de tendências psíquicas que lutam entre si, exatamente como vimos no sintoma histérico. A fórmula de que o sonho é a realização (disfarçada) de um desejo (reprimido) é a que melhor corresponde à natureza do sonho. O estudo do processo que transforma o desejo onírico latente no conteúdo onírico manifesto (o trabalho do sonho) nos proporcionou o que melhor sabemos da vida psíquica inconsciente.

Ora, o sonho não é um sintoma mórbido, mas uma produção da vida psíquica normal. Os desejos que ele apresenta como realizados são os mesmos que na neurose sucumbem à repressão. Ele deve a possibilidade de seu surgimento à circunstância favorável de que durante o estado do sono, que paralisa a motilidade do ser humano, a repressão é atenuada, tornando-se censura onírica. Mas, quando a formação do sonho vai além de certos limites, o sonhador lhe põe um fim e acorda assustado. Está provado, assim, que tanto na vida psíquica normal como na patológica existem as mesmas forças e os mesmos processos se desenvolvem entre elas. A partir da *Interpretação dos sonhos* a psicanálise teve um duplo significado, era não apenas uma nova terapia, mas também uma nova psicologia; pretendia ser levada

em conta não apenas por especialistas em doenças nervosas, mas por todos os que lidam com alguma das ciências humanas.^{**}

Mas a recepção que ela teve no mundo científico não foi cordial. Por cerca de uma década ninguém se ocupou dos trabalhos de Freud. Por volta de 1907 um grupo de psiquiatras suíços (Bleuler e Jung, em Zurique) chamou a atenção para a psicanálise, e então irrompeu — na Alemanha, sobretudo — uma tempestade de indignação que não foi realmente seletiva nos seus métodos e argumentos. Nisso a psicanálise partilhou o destino de muitas novidades, que após certo lapso de tempo tiveram reconhecimento geral. Entretanto, estava em sua natureza que despertasse uma oposição particularmente violenta. Ela feria os preconceitos da humanidade civilizada em alguns pontos bastante sensíveis, como que submetia todos os homens à reação analítica, ao desvelar o que por acordo geral fora reprimido no inconsciente, e desse modo forçou os contemporâneos a se comportarem como os doentes que, no tratamento analítico, evidenciam sobretudo suas resistências. É preciso também admitir que não era fácil convencer-se da correção das teorias psicanalíticas ou obter treinamento no exercício da psicanálise.

A hostilidade geral não pôde impedir, no entanto, que no curso da década seguinte a psicanálise se expandisse ininterruptamente em dois sentidos: no mapa geográfico, pois o interesse por ela surgia em número cada vez maior de países; e no campo das ciências humanas, pois encontrava aplicação em número sempre maior de disciplinas. Em 1909, G. Stanley Hall, presidente da Universidade Clark, em Worcester, Massachusetts, convidou Freud e Jung para ministrarem uma série de conferências sobre a psicanálise, que também foram amistosamente

recebidas. Desde então a psicanálise se tornou popular na América, embora justamente nesse país muita superficialidade e algum abuso se tenham ligado ao seu nome. Já em 1911, Havelock Ellis pôde constatar que a análise era exercida e cultivada não apenas na Áustria e na Suíça, mas igualmente nos Estados Unidos, Inglaterra, Índia, Canadá e também Austrália.

Nesse período de luta e florescimento inicial surgiram também as publicações dedicadas exclusivamente à psicanálise. Foram o *Jahrbuch für psychoanalytische und psychopathologische Forschungen* [Anuário de Pesquisas Psicanalíticas e Psicopatológicas], dirigido por Bleuler e Freud e editado por Jung (1909-14), que foi suspenso com a irrupção da Grande Guerra, a *Zentralblatt für Psychoanalyse* [Folha Central de Psicanálise] (1911), dirigida por Adler e Stekel, que logo foi substituída pela *Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse* [Revista Internacional de Psicanálise] (1913, atualmente em seu décimo volume); e também, desde 1912, a *Imago*, revista fundada por Rank e Sachs, voltada para a aplicação da psicanálise às ciências humanas. O grande interesse dos médicos anglo-americanos evidenciou-se em 1913, com a fundação da *Psychoanalytic Review* por White e Jelliffe, revista ainda hoje existente. Mais tarde, em 1920, nasceu o *International Journal of Psycho-Analysis* [Revista Internacional de Psicanálise], destinada especialmente à Inglaterra e dirigida por Ernest Jones. A *International Psychoanalytischer Verlag* [Editora Psicanalítica Internacional] e sua correspondente inglesa (International Psycho-Analytical Press) apresentam, sob o nome de Biblioteca Psicanalítica Internacional, uma série contínua de publicações psicanalíticas.

Naturalmente, a literatura da psicanálise não se acha apenas nessas edições periódicas, que são, em sua maioria, patrocinadas pelas associações psicanalíticas. Ela se encontra disseminada em inúmeros locais, tanto em publicações científicas como em literárias. Entre as revistas do mundo latino que dão especial atenção à psicanálise, cumpre destacar a *Revista de Psiquiatria*, dirigida por H. Delgado, em Lima (Peru).

Uma diferença essencial entre a segunda década da psicanálise e a primeira foi que o presente autor já não era mais o seu único defensor. Um círculo crescente de alunos e seguidores se juntara em torno dele, e o trabalho desses discípulos consistiu primeiramente na difusão das teorias da psicanálise, para depois lhes dar prosseguimento, completá-las e aprofundá-las. No decorrer dos anos, vários deles — como era inevitável — se afastaram, seguiram seus próprios caminhos ou se tornaram uma oposição que parecia ameaçar a continuidade do desenvolvimento da psicanálise. Entre 1911 e 1913 foram C. G. Jung, em Zurique, e Alfred Adler, em Viena, que, com suas tentativas de reinterpretar os fatos psicanalíticos e seus empenhos em desviar-se dos pontos de vista da psicanálise, geraram alguma comoção; mas logo se verificou que estas secessões não produziam dano duradouro. O sucesso temporário que lhes veio se explicava facilmente pelo fato de grande número de pessoas estar disposto a livrar-se da pressão das exigências psicanalíticas, não importando o caminho que assim lhes fosse aberto. A grande maioria dos colaboradores permaneceu firme e deu prosseguimento ao trabalho conforme as linhas indicadas. Vamos encontrar seus nomes repetidamente na exposição

seguinte, bastante breve, dos resultados da psicanálise em seus vários campos de aplicação.

IV

A ruidosa rejeição da psicanálise pelos médicos em geral não pôde impedir que seus seguidores a desenvolvessem conforme a intenção original, ou seja, como uma patologia e terapia especial das neuroses, uma tarefa que mesmo hoje em dia não foi totalmente realizada. Os inegáveis sucessos terapêuticos, que foram além de tudo o que até então se alcançara, incitavam constantemente a novos esforços, e as dificuldades que apareciam com o aprofundamento na matéria ocasionaram grandes mudanças na técnica analítica e significativas correções nas hipóteses e premissas da teoria.

No curso desse desenvolvimento, a técnica da psicanálise se tornou tão definida e delicada como a de qualquer outra especialidade médica. Muitas falhas são cometidas ao não se compreender esse fato, sobretudo na Inglaterra e na América, pois pessoas que adquiriram apenas um conhecimento literário da psicanálise acreditam-se capacitadas a empreender tratamentos analíticos, sem haver recebido treinamento especial. As consequências de tal conduta são nefastas, tanto para a ciência como para os doentes, e contribuíram bastante para o descrédito da psicanálise. Por isso a fundação da primeira policlínica psicanalítica (por M. Eitingon, em Berlim, 1920) foi um passo de enorme importância prática. Essa instituição se empenha, por um lado, em tornar a terapia analítica acessível a amplas camadas da população, e por outro lado se encarrega de preparar

médicos para a profissão de analista, num curso que envolve a condição de o aluno se submeter a uma análise.

Entre os conceitos auxiliares que possibilitam ao médico o domínio do material analítico, há que se mencionar o de “libido” em primeiro lugar. Libido significa primeiramente, na psicanálise, a força (imaginada como quantitativamente variável e mensurável) dos instintos sexuais (no sentido ampliado pela teoria psicanalítica) dirigidos para o objeto. Com o estudo subsequente houve a necessidade de justapor a essa “libido objetiva” uma “libido do Eu ou narcísica”, dirigida para o próprio Eu, e a interação dessas duas forças permitiu dar conta de um grande número de processos normais e patológicos da vida psíquica. Logo se fez a grande distinção entre as chamadas “neuroses de transferência” e as afecções narcísicas, as primeiras (histeria e neurose obsessiva) sendo propriamente os objetos da terapia analítica, enquanto as outras, as neuroses narcísicas, permitem investigação com o auxílio da análise, mas apresentam dificuldades fundamentais à influência terapêutica. É certo que a teoria psicanalítica da libido não se acha absolutamente concluída e que sua relação com uma teoria geral dos instintos não está esclarecida; a psicanálise é uma ciência jovem, em tudo incompleta, em acelerado desenvolvimento, mas neste ponto cabe assinalar como é equivocada a objeção de pansexualismo que frequentemente se faz a ela. Conforme essa objeção, a teoria psicanalítica não conhece outras forças psíquicas instintuais senão as puramente sexuais, e assim fazendo explora preconceitos populares, ao utilizar “sexual” não no sentido analítico, e sim vulgar.

A concepção psicanalítica teria de contar entre as afecções narcísicas também os transtornos que na psiquiatria são

denominados “psicoses funcionais”. Estava fora de dúvida que neuroses e psicoses não eram separadas por uma fronteira nítida, da mesma forma que saúde e neurose, e era natural recorrer, para explicar os enigmáticos fenômenos psicóticos, aos conhecimentos obtidos no estudo das neuroses, até então igualmente impenetráveis. O presente autor, em seu período de isolamento, já havia tornado parcialmente compreensível um caso de paranoia mediante a investigação psicanalítica, e evidenciado nessa inequívoca psicose os mesmos conteúdos (complexos) e um jogo de forças semelhante ao das simples neuroses.* Em bom número de psicoses E. Bleuler acompanhou os indícios do que chamava “mecanismos freudianos”, e C. G. Jung conquistou enorme prestígio como analista quando, em 1907, explicou os mais estranhos sintomas dos estágios finais da *dementia praecox* a partir das histórias individuais dos pacientes. O abrangente estudo de Bleuler sobre a esquizofrenia (de 1911) demonstrou, provavelmente de forma definitiva, a legitimidade dos pontos de vista psicanalíticos para a compreensão das psicoses.

Desse modo a psiquiatria se tornou o campo imediato de aplicação da psicanálise, e assim permaneceu desde então. Os pesquisadores que mais contribuíram para um aprofundado conhecimento analítico das neuroses, como K. Abraham, em Berlim, e S. Ferenczi, em Budapeste (para mencionar apenas os mais notáveis), destacaram-se também na elucidação analítica das psicoses. Insinuava-se cada vez mais, não obstante a oposição dos psiquiatras, a convicção da unidade e íntima relação de todos os transtornos que se apresentam como fenômenos neuróticos e psicóticos. Começa-se a compreender — principalmente na América, talvez — que o estudo psicanalítico das neuroses pode

ser a única preparação para o entendimento das psicoses, que a psicanálise deve possibilitar uma psiquiatria científica no futuro, que não mais se contente em descrever estranhos casos clínicos, evoluções incompreensíveis, e acompanhar a influência de grossos traumas anatômicos e tóxicos sobre um aparelho psíquico inacessível a nosso conhecimento.

V

Mas com sua importância para a psiquiatria a psicanálise não teria chamado a atenção do mundo intelectual ou conquistado um lugar na *History of our times*.** Tal efeito vem da relação da psicanálise com a vida psíquica normal, não com a patológica. Originalmente a pesquisa analítica não tinha outro objetivo senão investigar as condições de surgimento (a gênese) de alguns estados psíquicos doentios, mas nesse esforço veio a descobrir relações de importância fundamental, a francamente criar uma nova psicologia, de modo que foi inevitável reconhecer que a validade de tais descobertas não podia se limitar ao âmbito da patologia. Já sabemos quando foi obtida a prova decisiva da exatidão dessa conclusão. Foi quando se chegou à interpretação dos sonhos mediante a técnica analítica; dos sonhos, que são parte da vida psíquica das pessoas normais e que, na verdade, correspondem a produções patológicas que podem regularmente aparecer em condições de saúde.

Atendo-se às percepções*** psicológicas adquiridas pelo estudo dos sonhos, não restava senão um passo para poder proclamar a psicanálise a teoria dos processos psíquicos mais profundos, não diretamente acessíveis à consciência, “psicologia das

profundeza”, e para poder aplicá-la a quase todas as ciências humanas. Este passo consistiu na transição da atividade psíquica do indivíduo para as funções psíquicas dos povos e comunidades humanas, ou seja, da psicologia individual para a das massas, e muitas analogias surpreendentes levaram a ele. Havia-se descoberto, por exemplo, que nas camadas profundas da atividade mental inconsciente os opostos não são diferenciados um do outro, mas sim expressos pelo mesmo elemento. Já em 1884 o filólogo K. Abel havia sustentado (em “Sobre o sentido antitético das palavras primitivas”) que os mais antigos idiomas conhecidos tratavam os opostos de igual maneira. O antigo egípcio, por exemplo, possuía primeiramente uma só palavra para “forte” e “fraco”, e apenas depois os dois lados da antítese foram diferenciados mediante ligeiras modificações. Ainda nos mais recentes idiomas se acham claros vestígios desse sentido antitético, como na palavra alemã *Boden* [“sótão” ou “chão”], que designa tanto a parte mais alta como a baixa da casa — de modo semelhante a *altus* — “alto” e “fundo” — em latim. Assim, a equivalência de opostos no sonho é um traço arcaico universal do pensamento humano.

Para fornecer um exemplo de outro âmbito: é impossível escapar à impressão de total concordância entre os atos obsessivos de certos doentes obsessivos e as práticas religiosas de crentes do mundo inteiro. Alguns casos de neurose obsessiva se apresentam mesmo como uma caricatura de religião privada, de modo que é tentador equiparar as religiões oficiais a uma neurose obsessiva atenuada por sua natureza geral. Tal comparação, certamente revoltante para os crentes, mostrou-se psicologicamente fecunda, no entanto. Pois a psicanálise logo tomou

conhecimento das forças que lutam entre si na neurose obsessiva, até seus conflitos acharem singular expressão no cerimonial das ações obsessivas. Não se suspeitava de nada semelhante no caso do cerimonial religioso, até que foi possível, ao referir ou fazer remontar o sentimento religioso à relação com o pai, sua raiz mais profunda, evidenciar também ali uma situação dinâmica análoga. Esse exemplo, aliás, mostra ao leitor que também aplicada em áreas não médicas a psicanálise não pode deixar de ferir preconceitos bastante apreciados, de tocar em suscetibilidades profundamente enraizadas e, assim, despertar hostilidades de base essencialmente afetiva.

Se é lícito supor que as condições mais gerais da vida psíquica inconsciente (os conflitos entre impulsos instintuais, as repressões e satisfações substitutivas) se acham em toda parte, e se existe uma psicologia das profundezas que leva ao conhecimento dessas condições, então podemos razoavelmente esperar que a aplicação da psicanálise aos mais diversos âmbitos da atividade espiritual humana produzirá resultados importantes e até agora inalcançáveis. Num estudo substancial,* Otto Rank e Hanns Sachs se empenharam em resumir o que o trabalho dos psicanalistas pôde fazer nesse sentido até 1913. A limitação de espaço me impede de completar aqui a sua lista. Posso apenas destacar as conclusões mais relevantes e acrescentar alguns pormenores.

Deixando de lado impulsos internos pouco conhecidos, pode-se dizer que o principal motor da evolução cultural do ser humano foi a privação externa real, que lhe negou a cômoda satisfação de suas naturais necessidades e o expôs a perigos imensos. Essa frustração externa o obrigou à luta com a realidade, luta

que resultou em parte na adaptação a ela, em parte no domínio dela, mas também levou ao trabalho em comum e à convivência com os semelhantes, o que já implicava uma renúncia a vários impulsos instintuais que não podiam ser satisfeitos socialmente. Com os subseqüentes progressos na civilização cresceram também as exigências da repressão. Afinal, a civilização se baseia na renúncia instintual, e cada indivíduo, em seu caminho da infância à maturidade, repete em sua própria pessoa esse desenvolvimento da humanidade rumo a uma sensata resignação. A psicanálise mostrou que são sobretudo, embora não exclusivamente, impulsos instintuais sexuais que sucumbem a essa repressão^{**} cultural. Uma parte deles exibe a valiosa característica de se deixar desviar dos objetivos imediatos, e assim põe sua energia, como tendências “sublimadas”, à disposição do desenvolvimento cultural. Mas outra parte permanece no inconsciente como desejos insatisfeitos e urge por uma satisfação qualquer, mesmo que deformada.

Vimos que uma porção da atividade mental humana se empenha em lidar com o mundo externo real. A psicanálise nos diz também que outra parte da produção psíquica, particularmente estimada, serve à realização de desejos, à satisfação substitutiva dos desejos reprimidos que, desde a infância, habitam insatisfeitos a alma de cada pessoa. Entre essas criações — cujo nexos com um inapreensível inconsciente sempre foi suspeitado — estão os mitos, a literatura e a arte; e, de fato, o trabalho dos psicanalistas lançou bastante luz sobre os campos da mitologia, dos estudos literários e da psicologia do artista. Basta mencionar a obra de O. Rank como exemplo. Demonstrou-se que os mitos e fábulas admitem interpretação tal como os sonhos, acompanharam-se os emaranhados caminhos que vão do impulso do desejo

inconsciente até a realização na obra de arte, chegou-se a compreender o efeito emocional da obra de arte sobre o sujeito receptor e a esclarecer, no artista propriamente, tanto sua íntima afinidade como sua diferença em relação ao neurótico, e mostrou-se o nexos entre sua disposição inata, suas vivências ocasionais e sua obra. A apreciação estética da obra de arte e a elucidação do talento artístico não podem ser consideradas tarefas da psicanálise. Parece, no entanto, que ela está em condições de dar a palavra decisiva em todas as questões atinentes à vida da fantasia no ser humano.

Em terceiro lugar, a psicanálise nos fez compreender, para nosso contínuo assombro, o papel extremamente importante que o chamado “complexo de Édipo”, ou seja, a relação afetiva da criança com os dois genitores, tem na vida psíquica do ser humano. Tal assombro é atenuado ao se perceber que o complexo de Édipo é o correlato psíquico de dois fatos biológicos fundamentais: a longa dependência infantil do ser humano e o modo singular como sua vida sexual atinge um primeiro ápice dos três aos cinco anos e, após um período de inibição, recomeça na puberdade. Então vimos que um terceiro, seriíssimo aspecto da atividade intelectual humana, que criou as grandes instituições da religião, do direito, da ética e todas as formas de organização social, objetiva, no fundo, possibilitar ao indivíduo a superação de seu complexo de Édipo e guiar sua libido desde as vinculações infantis àquelas sociais, definitivamente desejadas. As aplicações da psicanálise ao estudo da religião^{***} e à sociologia (pelo presente autor, Th. Reik e O. Pfister), que levaram a esse resultado, ainda são novas e insuficientemente avaliadas, mas não há dúvida de que estudos subseqüentes aumentarão o grau de certeza dessas importantes explicações.

Devo acrescentar, como que em apêndice, que também a pedagogia não pode deixar de aproveitar as sugestões que lhe são oferecidas pela investigação psicanalítica da vida psíquica das crianças; e que entre os terapeutas há algumas vozes (Groddeck, Jelliffe) que também consideram promissor o tratamento psicanalítico de graves doenças orgânicas, pois em muitas delas colabore também um fator psíquico, sobre o qual é possível ter influência.

É lícito formular a expectativa de que a psicanálise — da qual expusemos aqui o desenvolvimento e as realizações até agora, de maneira concisa e insatisfatória — será um importante fermento na evolução cultural das próximas décadas e ajudará a aprofundar nossa compreensão do mundo e rechaçar algumas coisas percebidas como prejudiciais na vida. Não se deve esquecer, porém, que a psicanálise sozinha não pode fornecer uma visão do mundo completa. Aceitando-se a distinção que propus, em que o aparelho psíquico é decomposto num Eu voltado para o mundo externo e provido de consciência e num Id inconsciente, dominado por suas necessidades instintuais, então a psicanálise deve ser designada como uma psicologia do Id (e dos influxos deste sobre o Eu). Logo, em cada campo do saber ela pode apenas fazer contribuições que devem ser completadas a partir da psicologia do Eu. Se tais contribuições muitas vezes contêm o essencial dos fatos, isso apenas corresponde à importância que o inconsciente psíquico, por muito tempo ignorado, pode reivindicar em nossa vida.

*Famoso hospital parisiense, onde Freud fez estágio com o neuropatologista Charcot.

**No original se acha *Zerfall* (*Dissoziation*). Freud utilizou a palavra germânica equivalente ao termo latino e este em seguida, entre parênteses; por isso não consideramos necessário encontrar outro sinônimo para verter *Zerfall* e manter “dissociação” entre parênteses. Com exceção da espanhola, as versões consultadas preferiram fazer assim, recorrendo a *fragmentación* (a argentina da Amorrotu), *disgregazione* (a italiana da Boringhieri) e *disintegration* (a *Standard* inglesa) para traduzir *Zerfall*. Nos dicionários de estrangeirismos — de publicação costumeira nos países de língua alemã — esse termo é geralmente dado como sinônimo de “dissociação”.

***“Impulso”: *Impuls*, no original — ou seja, Freud emprega aqui o mesmo termo latino.

“Afastado”: o verbo original é *abdrängen*, formado de *drängen*, que significa “pressionar, empurrar, impelir”, e do prefixo *ab*, que indica afastamento, e que um dicionário alemão-português (o *Michaelis*, Nova York: Ungar, s.d.) traduz por “afastar empurrando”; nota-se que é aparentado ao verbo *verdrängen*, normalmente traduzido por “reprimir” ou “recalcar” nos textos de Freud em português. As versões estrangeiras consultadas recorrem, nesse ponto, a: *desviado*, *esforzado afuera*, *desviato*, *prevented from*.

***Geisteswissenschaften*, literalmente “ciências do espírito” — que é como os tradutores consultados vertem a palavra, no singular ou no plural, com exceção do inglês Strachey, que prefere *mental science*; cf. mais adiante, na seção v, “ciência literária” e “ciência da religião”.

***“Forças psíquicas instintuais”: *seelische Triebkräfte* — também pode ser traduzido por “forças motrizes da psique”, como em algumas das versões consultadas: *energias instintivas psíquicas*, *fuerzas pulsionales*, *forze motrici psichiche*, *mental motive forces*.

*Cf. “Novas observações sobre as neuropsicoses de defesa”, parte III (1896).

** Alusão ao título do volume para o qual foi escrito este trabalho.

***“Percepções”: *Einsichten* — nas versões estrangeiras consultadas: *atisbos*, *intelecciones*, *prospettive*, *discoveries*.

* O. Rank e H. Sachs, *Die Bedeutung der Psychoanalyse für die Geisteswissenschaften* [A importância da psicanálise para as ciências humanas], Wiesbaden, 1913.

**“Repressão”: *Unterdrückung* — nas versões consultadas: *repressão*, *sofocación*, *repression*, *suppression*. Normalmente traduzimos esse termo alemão por “supressão” e deixamos “repressão” para *Verdrängung* — caso se queira fazer distinção clara entre um e outro conceito, o que é discutível —, mas nota-se que aí são claramente sinônimos, pois o segundo foi usado poucas linhas acima nesse mesmo sentido. Cf. capítulo sobre *Verdrängung* em Paulo César de Souza, *As palavras de Freud*, op. cit.

***“Estudo da religião”: *Religionswissenschaft*, literalmente “ciência da religião” — lembrando-nos, mais uma vez, que em alemão o termo *Wissenschaft* é empregado em sentido mais amplo do que em português; cf. “estudos literários” (*Literaturwissenschaft*), no parágrafo anterior.